



Nuansa
Fajar
Cemerlang

DETEKSI FAKTOR RISIKO HIPERTENSI YANG DAPAT DIMODIFIKASI DALAM UPAYA PERILAKU PENCEGAHAN KLIEN HIPERTENSI

Faisal Ibnu
Rina Nur Hidayati



DETEKSI FAKTOR RISIKO HIPERTENSI YANG DAPAT DIMODIFIKASI DALAM UPAYA PERILAKU PENCEGAHAN KLIEN HIPERTENSI

**Dr. Faisal Ibnu, S.Pd. S.Kep.Ns. M.Kes.
Rina Nur Hidayati, M.Kep.Sp.Kep.Kom.**



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**Deteksi Faktor Risiko Hipertensi
Yang Dapat Dimodifikasi dalam Upaya
Perilaku Pencegahan Klien Hipertensi**

Penulis: Dr. Faisal Ibnu, S.Pd. S.Kep.Ns.M.Kes.
Rina Nur Hidayati, M.Kep.Sp.Kep,Kom.

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan
Tata Letak : Achmad Faisal

ISBN: 978-634-7139-73-3

Cetakan Pertama: Februari, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram : @bimbel.optimal



PENERBIT:
Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jakarta Barat, 11480
Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN
PENANGGUNG JAWAB

Deteksi faktor risiko hipertensi yang dapat dimodifikasi dalam upaya perilaku pencegahan klien hipertensi / Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Kes., Rina Nur Hidayati, M.Kep., Sp.Kep.Kom.

EDISI

Cetakan pertama, Februari 2025

PUBLIKASI

Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025

DESKRIPSI FISIK

iv, 83 halaman ; 30 cm

IDENTIFIKASI

ISBN 978-634-7139-73-3

SUBJEK

Hipertensi

KLASIFIKASI

616.132 [23]

PERPUSNAS ID

<https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1186182>

Prakata

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kekuatan-Nya, sehingga penulisan buku keperawatan yang berjudul **Deteksi Faktor Risiko Hipertensi Yang Dapat Dimodifikasi dalam Upaya Perilaku Pencegahan Klien Hipertensi** dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berupaya mengarahkan dan membimbing penulis baik pada aspek penulisan maupun motivasi yang kuat sehingga buku ini dapat tersusun sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Buku ini berisi tentang konsep dasar hipertensi, faktor risiko Hipertensi, Upaya Pencegahan Hipertensi dan asosiasi faktor risiko terhadap upaya pencegahan hipertensi.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan para perawat sejawat sebagai bahan bacaan dan acuan dasar dalam mendeteksi faktor risiko hipertensi untuk mencegah sedini mungkin terjadinya hipertensi dalam keluarga.

Januari, 2025

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Hipertensi dan Faktor Risiko Hipertensi	5
A. Pengertian Hipertensi	5
B. Faktor Risiko Hipertensi	8
C. Dampak Hipertensi	13
D. Pengelolaan Hipertensi	15
Bab 3 Perilaku Upaya Pencegahan Hipertensi	27
A. Pengertian	27
B. Upaya Pencegahan Hipertensi.....	34
Bab 4 Pendekatan dan Analisis Faktor Risiko Hipertensi terhadap Perilaku Pencegahan.....	38
A. Pendekatan Teoritis	38
B. Pendekatan Analisis	42
Bab 5 Asosiasi Faktor Risiko Hipertensi dengan Upaya Pencegahan Klien Hipertensi.....	50
A. Pencegahan Hipertensi melalui Gaya Hidup Sehat.....	50
B. Asosiasi Faktor Risiko Hipertensi dengan Upaya Pencegahan Klien Hipertensi.....	52
Bab 6 Penutup	59
Daftar Pustaka	62
Glosarium	70
Profil Penulis.....	71

Bab 1

Pendahuluan

Hipertensi masih menjadi masalah utama di dunia, baik di negara maju maupun di negara – negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut *American Heart Association (AHA)* bahwa penduduk Amerika yang berusia diatas usia 20 tahun yang menderita penyakit hipertensi telah mencapai angka hingga 74,5 juta jiwa, akan tetapi hampir sekitar 90-95% kasus tidak diketahui penyebabnya (Dinkes, 2019). Data *World Health Organization (WHO)* tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 Miliar orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penderita penyakit hipertensi masih cukup tinggi, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliyar orangyang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 10,44 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya (Kemenkes RI., 2019). Menurut WHO, di seluruh dunia sekitar 972 juta orang atau 26,4% orang di seluruh dunia mengidap hipertensi dan angka ini kemungkinan akan mengalami peningkatan menjadi 29,2% di tahun 2025.

Dari 972 juta orang mengidap hipertensi, 333 juta orang terdapat di negara maju dan sisanya 639 di negara berkembang, termasuk Indonesia (Evi Martina, et al, 2022). Jumlah orang dengan tekanan darah tinggi meningkat dari tahun ke tahun, Pada tahun 2013 ada 1,13 miliar orang di seluruh dunia mengalami tekanan darah tinggi. Di dunia, ada 1,5 miliar orang yang diperkirakan meninggal tiap tahunannya, 9,4 juta orang karena komplikasi (Sunarmi, Kurdaningsih, & Rizi, 2020).

Prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia >18 tahun semakin meningkat yaitu tahun 2007: 25,8%, tahun 2013; 31,7%⁵, tahun 2018: 34% dan tahun 2023: 30,8% (SKI, 2023). Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa prevalensi klien hipertensi di Indonesia masih cukup meningkat. Prevalensi penderita hipertensi di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir meningkat mencapai 14,10% terutama berdasarkan jenis kelamin wanita mencapai 52,3% (Profil Kesehatan Jawa Timur, 2021). Prevalensi penderita hipertensi tahun 2022 di Kabupaten Mojokerto mencapai 30,4% (Satu Data Palapa Mojokerto, 2023). Berdasarkan data di Puskesmas Bangsal Mojokerto jumlah penderita hipertensi mencapai 29,30% (Dinkes Mojokerto, 2021).

Banyak faktor yang mempengaruhi masih tingginya prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia. Berdasarkan hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko terjadinya hipertensi antara lain: faktor umur, tingkat pendidikan, pengetahuan, persepsi, pengalaman sebelumnya, keturunan/genetik, berat badan, obesitas, aktivitas fisik (olahraga), konsumsi makanan dan minuman (asinan, berlemak,

gorengan, minuman beralkohol), kebiasaan merokok dan status gizi (Aisyah, 2009; Andrea, 2013; Barbosa et.al, 2017; Januar & Maywati, 2014; Kartikasari, 2012; Yusuf, 2014; Widyaningsih & Latifah, 2008; Utami, et.al, 2013; Putri, 2014). Diantara faktor penyebab tersebut, faktor yang paling memungkinkan resiko kekambuhan hipertensi adalah faktor pola makan dan pola hidup sehari-hari (Ambarika, et.al, 2015; Imron Rahmanto, et.al, 2017; Barbosa et.al, 2017; Januar & Maywati, 2014; Yunilasari, 2014; Yusuf, 2014; Situmorang, 2015). Menurut WHO, terdapat lima faktor risiko umum PTM, yakni penggunaan tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, pola makan yang tidak sehat, serta paparan polusi udara. Adapun faktor utama terjadinya hipertensi dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah (usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga) dan faktor risiko yang dapat diubah (obesitas, obesitas sentral, merokok, konsumsi buah dan sayur yang kurang, aktivitas fisik yang kurang, konsumsi minuman beralkohol, dan profil lipid yang abnormal (SKI, 2023).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan dan menurunkan prevalensi klien penyakit hipertensi terutama upaya dalam mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan klien hipertensi, baik upaya fisik (bio), psikis dan sosial. Berdasarkan beberapa penelitian teridentifikasi upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak fisik klien hipertensi antara lain pemberian nafas dalam untuk menurunkan tekanan darah (Barek, 2010), pengaturan diit termasuk diet rendah lemak, rendah garam, menghindari konsumsi buah durian, atau minum minuman beralkohol, pengaturan status gizi (Utami et

al., 2013; Yusuf, et.al, 2014), pembatasan perilaku merokok, pengaturan perilaku olahraga (Utami et al., 2013), pemberian aktivitas fisik yaitu dengan penjadwalan aktivitas fisik selama 6 minggu mampu membantu mengendalikan dan mencegah kenaikan tekanan darah pada klien hipertensi dalam keluarga (Putri, 2014; Yusuf, et.al, 2014; Rosario, 2015), senam ergonomis (Hapsari et al., 2015), mengobati penyakit penyerta seperti kencing manis, hipertiroid, kolesterol tinggi, resistensi insulin, rematik, gout dan sebagainya (Yusuf et.al, 2014), dan Rosario (2015) melakukan pemberian jus terong pirus dalam upaya mengatasi berbagai dampak fisik pada klien hipertensi.

Upaya lain untuk mengurangi dampak psikologi klien hipertensi antara lain melalui: 1) Pendekatan model stres adaptasi Stuart yang menunjukkan bahwa terapi relaksasi progresif, *thought stopping*, terapi kognitif, terapi psikoedukasi keluarga dan terapi kelompok suportif mampu membantu menurunkan tingkat stress pada klien hipertensi lansia (Dewi, 2012; Utami et al., 2013); 2) Pendekatan model stres adaptasi Stuart dan model adaptasi ROY menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat stress dan terdapat peningkatan kemampuan *Supportive Therapy* (ST) dan *Family Psychoeducator* (FPE) (Pase, 2014); 3) Pelatihan relaksasi autogenik untuk menurunkan tingkat stress klien hipertensi (Tajuddin & Ramdhani, 2011); 4) Pemberian Model Keperawatan Sugesti Tidur untuk menurunkan tekanan darah (Haryanto, 2015); 5) Yusuf et.al, (2014) menunjukkan bahwa untuk mengurangi dampak psikologi klien hipertensi dengan cara menghindari stres melalui gaya hidup yang lebih santai.

Bab 2

Hipertensi dan Faktor Risiko Hipertensi

A. Pengertian Hipertensi

Hipertensi arterial sistemik adalah kondisi persisten yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau ≥ 90 mmHg. Hipertensi menimpa sebagian besar Populasi orang dewasa di seluruh dunia dan semakin banyak menyerang anak-anak (Black & Elliott, 2013). Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik lebih dari 140/90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit saat keadaan istirahat. Peningkatan tekanan darah dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal, jantung koroner, dan stroke bila tidak dideteksi secara dini dan pengobatan yang memadai (Kemenkes RI, 2014).

Hipertensi adalah kondisi pokok yang mendasari banyak bentuk penyakit kardiovaskuler. Hipertensi merupakan faktor penyebab utama kematian akibat stroke dan faktor yang dapat memperberat infark miokard (serangan jantung). Kondisi tersebut adalah merupakan gangguan yang paling umum pada pasien dengan tekanan darah tinggi. Sejalan dengan bertambahnya usia, hampir setiap orang akan mengalami kenaikan tekanan darah (Arif, Amalia, Sesrianty, & Kartika, 2019). Hipertensi menjadi masalah pada lanjut usia karena sering ditemukan faktor utama penyakit koroner. Lebih dari separuh kematian di atas usia 60 tahun disebabkan oleh penyakit jantung dan serebrovaskuler (Fitrina & Wiryanti, 2018).

Berdasarkan penyebab, hipertensi diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Hipertensi Primer, merupakan peningkatan tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih pada usia lebih dari 18 tahun yang penyebabnya tidak diketahui (Setiati et al., 2014). Penyebab hipertensi primer bersifat multi-faktorial yang timbul akibat interaksi dari berbagai faktor risiko antara lain bertambahnya usia, stress psikologis, faktor genetik (keturunan), faktor gaya hidup diantaranya pola makan yang tidak teratur, obesitas, kebiasaan merokok dan kurang beraktivitas serta faktor lingkungan. Kurang lebih 90% dari jumlah penderita hipertensi diperkirakan termasuk dalam kategori hipertensi primer. Penatalaksanaan hipertensi primer sering dilakukan dengan cara membatasi konsumsi kalori bagi mereka

yang kegemukan (obesitas), membatasi konsumsi garam, menurunkan konsumsi alkohol, menghentikan rokok, meningkatkan asupan buah dan sayur dan meningkatkan aktivitas fisik. Pemberian obat antihipertensi juga diperlukan untuk menurunkan tekanan darah itu sendiri akan tetapi harus disesuaikan dengan jenis dan kombinasi obat serta harus disesuaikan dengan kondisi tekanan darah awal dan ada tidaknya komplikasi (Kemenkes RI, 2014; Setiati et al., 2014).

2. Hipertensi Sekunder, hipertensi sekunder adalah hipertensi yang penyebab pastinya sudah dapat diketahui. Hipertensi sekunder terjadi karena disebabkan adanya kerusakan suatu organ. Hipertensi sekunder ini antara lain hipertensi jantung, hipertensi penyakit ginjal, hipertensi penyakit jantung dan ginjal, hipertensi diabetes melitus, dan hipertensi sekunder lain yang tidak spesifik. Penyebab umumnya penderita hipertensi adalah penyakit ginjal sekitar 5-10% dan sekitar 1-2% disebabkan oleh penyakit hormonal terutama penggunaan pil KB (Kemenkes RI, 2014; Setiati et al., 2014).

Pada pemeriksaan fisik, tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah yang tinggi, tetapi dapat pula ditemukan perubahan pada retina, seperti perdarahan, eksudat, penyempitan pembuluh darah, dan pada kasus berat dapat ditemukan edema pupil atau edema pada diskus optikus. Menurut Price, gejala hipertensi antara lain sakit kepala bagian belakang, kuku kuduk, sulit tidur, gelisah kepala pusing, dada berdebar-debar, lemas,

sesak nafas dan berkeringat. Gejala akibat komplikasi hipertensi yang pernah dijumpai meliputi gangguan penglihatan, saraf, jantung, fungsi ginjal dan gangguan serebral (otak) yang mengakibatkan kelumpuhan dan gangguan kesadaran hingga koma (Black & Elliott, 2013; Klaudia, 2021). Manifestasi klinis yang sering tampak, pada beberapa klien hipertensi antara lain mengeluh sakit kepala, pusing, lemas, sesak nafas, kelelahan, kesadaran menurun, mual, muntah, gelisah, jantung berdebar, mata berkunang-kunang, kelemahan otot, epitaksis bahkan ada yang mengalami perubahan mental. Manifestasi klinis awal sindrom ini sering ada sebelum tekanan darah terdeteksi, oleh karena itu hipertensi tidak dapat diklasifikasikan dengan angka bulat (diskrit) (Black & Elliott, 2013; Setiati et al., 2014).

B. Faktor Risiko Hipertensi

Banyak faktor risiko yang memengaruhi kejadian hipertensi di Indonesia. Berdasarkan hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko terjadinya hipertensi antara lain: faktor umur > 36 tahun (Aisyah, 2009; Januar & Maywati, 2014; Kartikasari, 2012) Umur responden yang berisiko terjadi hipertensi adalah umur lebih dari 36 tahun. Faktor risiko kedua adalah riwayat keluarga termasuk besar keluarga (Fitriana et al., 2012; Januar & Maywati, 2014; Kartikasari, 2012; Widyaningsih & Latifah, 2008). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

riwayat keluarga termasuk type keluarga merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi dalam keluarga.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi terjadinya hipertensi adalah pola makan. Pola makan ini termasuk konsumsi asin, konsumsi lemak jenuh, penggunaan minyak *jilantah*, konsumsi alkohol (Andrea, 2013; Fitriana et al., 2012; Situmorang, 2015) dan faktor kebiasaan merokok (Aisyah, 2009; Januar & Maywati, 2014; Kartikasari, 2012; Rahmawati et al., 2015; Ronaldy & Bungawati, 2013; Situmorang, 2015; Prasetyo, 2014). Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa adanya kebiasaan atau pola makan terutama mengkonsumsi asin-asinan, lemak, penggunaan minyak *jilantah* dan kebiasaan mengkonsumsi alkohol serta kebiasaan merokok merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi dalam keluarga.

Faktor risiko lain yang mempengaruhi terjadinya hipertensi adalah aktivitas fisik, termasuk tidak biasa berolahraga, olah raga tidak ideal (Aisyah, 2009; Andrea, 2013; Fitriana et al., 2012). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas fisik termasuk kurangnya beraktivitas fisik dan olah raga tidak teratur merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi dalam keluarga. Adanya berat badan yang meningkat atau obesitas juga merupakan faktor risiko terjadinya hipertensi (Barbosa, 2017; Fitriana et al., 2012; Kartikasari, 2012; Widyaningsih & Latifah, 2008; Yunilasari, 2014). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa berat badan merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi. Penelitian lainnya

menjelaskan bahwa faktor risiko terjadinya hipertensi sangat berkaitan dengan faktor keturunan atau genetik (Fitriana et al., 2012; Situmorang, 2015; Yunilasari, 2014) faktor pengetahuan, persepsi, dan pengalaman sebelumnya (Ambarika et al., 2015), faktor psikologis atau tingkat stress (Aisyah, 2009; Andrea, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat banyak faktor risiko yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit hipertensi dalam keluarga antara lain: umur, berat badan, obesitas, status gizi, aktivitas fisik (olahraga), konsumsi makanan dan minuman (asinan, berlemak, jantah, alkohol), kebiasaan merokok, keturunan/genetik, pengetahuan, persepsi, pengalaman sebelumnya, faktor psikologis atau tingkat stress.

Menurut P2PTM Kemenkes.go.id (2023) faktor risiko yang mempengaruhi hipertensi ada 2, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah.

1. **Faktor risiko yang tidak dapat diubah**, antara lain: usia, jenis kelamin, dan faktor genetik. Tekanan darah cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Usia semakin tua, akan semakin besar kemungkinan terkena tekanan darah tinggi. Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC), jenis kelamin wanita memiliki kemungkinan yang sama dengan pria untuk mengembangkan tekanan darah tinggi di beberapa titik selama hidup mereka. Faktor risiko yang tidak dapat diubah selanjutnya yaitu riwayat keluarga (genetik). Gen

memainkan beberapa peran dalam tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan kondisi terkait lainnya.

2. **Faktor risiko yang dapat diubah**, meliputi obesitas, alkohol, merokok, diet tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik.

Obesitas: Kondisi obesitas artinya seseorang memiliki kelebihan berat badan dan lemak tubuh. Orang dengan kelebihan lemak tubuh, maka jantung pun harus bekerja lebih keras untuk memompa darah dan oksigen ke seluruh tubuh. Seiring waktu, tekanan pada jantung dan pembuluh darah pun menjadi bertambah. Selain tekanan darah tinggi, kelebihan berat badan juga dapat memicu penyakit jantung dan diabetes, hingga penyakit berbahaya lainnya.

Alkohol: Konsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko hipertensi. Hal ini karena alkohol menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan peningkatan aliran darah dan detak jantung secara simultan. Sama seperti obesitas, kecanduan alkohol dapat menyebabkan permasalahan jantung, stroke, dan aritmia.

Merokok: Salah satu kandungan rokok adalah nikotin, dimana nikotin dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan menghirup karbon monoksida yang dihasilkan rokok, sehingga mengurangi jumlah oksigen yang dibawa oleh darah. Hal ini dapat merusak jantung dan pembuluh darah, termasuk meningkatkan hipertensi.

Stres: Tingkat stres yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Hal ini karena tubuh menghasilkan gelombang hormon saat seseorang berada dalam situasi stres. Hormon inilah yang akan meningkatkan tekanan darah sehingga menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan pembuluh darah menyempit.

Diet tidak sehat: Diet tidak sehat diantaranya rendah serat, tinggi garam, tinggi kalori, dan tinggi gula sangat berisiko terjadi peningkatan tekanan darah. Hasil penelitian Tunnur (2021) yang menemukan kaitan antara tekanan darah tinggi dan konsumsi natrium. Dimana dengan mengonsumsi natrium terlalu banyak dapat meningkatkan kandungan natrium dalam cairan ekstraseluler tersebut menjadi meningkat. Meningkatnya cairan ekstraseluler dapat mengakibatkan peningkatan volume darah yang dapat menyebabkan hipertensi (Salman et al., 2020). Hal ini juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Putro (2017) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola konsumsi sumber natrium dengan tekanan darah. Dimana adanya kebiasaan mengonsumsi makanan asin (garam atau natrium) berisiko menderita hipertensi sebesar 3-9 kali dibandingkan orang yang tidak mempunyai kebiasaan mengonsumsi makanan garam (natrium).

Kurang aktivitas fisik: Aktivitas fisik dan olahraga akan meningkatkan aliran darah melalui semua arteri tubuh, yang menyebabkan pelepasan hormon alami dan sitokin

yang akan mengendurkan pembuluh darah. Aktivitas fisik dan olahraga pada akhirnya mampu menurunkan tekanan darah sekaligus meningkatkan risiko kelebihan berat badan (Setiati et al., 2014; Sutanto, 2010).

C. Dampak Hipertensi

Menurut berbagai sumber dan penelitian menunjukkan bahwa dampak penyakit hipertensi sangat banyak dan bervariasi, antara lain dapat berdampak pada kondisi fisik, psikis dan sosial klien.

Dampak fisik pada klien hipertensi dapat berupa kerusakan organ ginjal, pendarahan pada selaput bening mata (retinopati), pecahnya pembuluh darah di otak (stroke) dan kelumpuhan) (Elliot & Black, 2012; Palomo-Piñón et al., 2016; Setiati et al., 2014; LIPI, 2015; Sutanto, 2010). Hal ini juga dijelaskan berdasarkan penelitian Andrea (2013) bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara riwayat Hipertensi dengan penyakit ginjal kronik (Andrea, 2013; Palomo-Piñón et al., 2016; Sutanto, 2010).

Berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dampak fisik hipertensi antara lain: terjadinya kerusakan ginjal, pendarahan pada selaput bening mata, pecahnya pembuluh darah di otak (stroke), kelumpuhan dan penyakit ginjal kronik.

Dampak psikologi bagi klien hipertensi dapat berupa sulit membedakan emosi. Kondisi ini dijelaskan oleh seorang ahli psikologi dari Clemson Universitas, Amerika Serikat,

James A. McCubbin, sesuai hasil penelitiannya yang membuktikan bahwa klien hipertensi akan mengalami penurunan kemampuan dalam mengenali rasa marah, takut, sedih dan ekspresi wajah (Mora, 2014). Berdasarkan hasil penelitian tersebut jelas bahwa dampak psikologi hipertensi antara lain sulit membedakan emosi karena klien hipertensi mengalami penurunan kemampuan dalam mengenali perasaan marah, takut, sedih dan ekspresi wajah. Klien hipertensi juga dapat mengalami kecemasan, rasa takut, tidak nyaman, depresi atau stress, dan perasaan tidak berdaya / tidak ada harapan.

Dampak sosial ekonomi pada klien hipertensi antara lain dapat berupa kesulitan dalam menjalankan rutinitas pekerjaannya dan adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya secara optimal sebagai akibat dari adanya kelemahan atau keterbatasan kemampuan dan keluhan lain akibat hipertensi yang diderita. Adanya efek samping obat dan aturan program pengobatan serta pengobatan yang lama juga menyebabkan klien hipertensi mengalami kecemasan, rasa takut, tidak nyaman, depresi atau stress dan perasaan tidak berdaya / tidak ada harapan. Lamanya pengobatan juga menyebabkan masalah terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga untuk program pengobatan klien hipertensi (Mora, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut jelas bahwa dampak sosial ekonomi klien hipertensi dapat berupa mengalami kesulitan dalam menjalankan rutinitas pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya

secara optimal sebagai akibat dari adanya kelemahan atau keterbatasan kemampuan dan keluhan lain akibat hipertensi fisik. Adanya efek samping obat dan aturan program pengobatan yang lama menyebabkan masalah terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga untuk program pengobatan klien hipertensi.

D. Pengelolaan Hipertensi

Pengelolaan klien hipertensi menurut berbagai sumber, dapat dilakukan melalui 2 pendekatan yaitu pendekatan Non-farmakologi dan Farmakologi.

1. Pengelolaan Non Farmakologi

Pendekatan nonfarmakologi pada klien hipertensi merupakan penanganan awal sebelum diberikan obat-obatan anti hipertensi. Sedangkan pada pasien hipertensi yang terkontrol, pendekatan nonfarmakologi ini dapat membantu pengurangan dosis obat-obatan anti hipertensi pada sebagian besar penderita hipertensi. Pengelolaan nonfarmakologi ini dikenal dengan modifikasi gaya hidup antara lain: menurunkan berat badan, mengurangi asupan garam, mengurangi alkohol, berhenti merokok, meningkatkan asupan buah dan sayur serta meningkatkan aktivitas fisik (Junaedi et al., 2013; Setiati et al., 2014).

Peran perawat dalam pengelolaan hipertensi non farmakologi sangat penting karena perawat mempunyai kemampuan melakukan tugas independen dan interdependen dalam melaksanakannya (Junaedi et al.,

2013; Setiati et al., 2014). Menurut beberapa ahli dan hasil penelitian bahwa pengelolaan nonfarmakologi sama pentingnya dengan pengobatan farmakologi, terutama pada pengelolaan hipertensi derajat I. Pengelolaan nonfarmakologi dapat dipakai sebagai pelengkap untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih baik pada klien hipertensi karena dapat mengurangi risiko kejadian gangguan pada sistem kardiovaskuler (Junaedi et al., 2013; Setiati et al., 2014).

Pendekatan nonfarmakologi yang dilakukan pada klien hipertensi antara lain:

a. Menurunkan faktor risiko

Corwin, (2012) menjelaskan bahwa berhenti merokok penting untuk mengurangi efek jangka panjang hipertensi karena asap rokok diketahui menurunkan aliran darah ke berbagai organ dan dapat meningkatkan beban kerja jantung. Selain dianjurkan berhenti merokok, klien hipertensi juga harus mengurangi asupan alcohol tidak lebih dari 2 kali minum/hari (Setiati et al., 2014). Berdasarkan hasil penelitian eksperimental bahwa pengurangan berat badan sampai sekitar 10 kg berhubungan langsung dengan penurunan tekanan darah rata-rata 2-3 mmHg per kg berat badan.

b. Aktivitas fisik

Aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur sangat bermanfaat untuk mengatur tekanan darah, dan

menjaga kebugaran tubuh. Aktivitas fisik antara lain jogging, berenang sangat baik dilakukan untuk penderita hipertensi. Melakukan olahraga secara teratur, minimal 3 kali seminggu mampu menurunkan tekanan darah walaupun berat badan belum tentu turun (Gunawan-Lany, 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas teratur terbukti mampu menurunkan tekanan perifer sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Hal ini karena aktivitas fisik atau olahraga dapat menimbulkan perasaan senang, santai dan dapat membantu mengurangi berat badan sehingga dapat menurunkan tekanan darah (Gunawan-Lany, 2005). Setiati et. al., (2014) menambahkan bahwa melakukan aktivitas dengan berjalan 30 menit / hari selama 5 hari / minggu maka akan mengurangi risiko gangguan kardiovaskuler. Hasil penelitian Dyah Samsiati, Nurhamidi and Rosihan Anwar (2023) menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi dengan nilai p value: 0,007.

Putri (2014) menjelaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan olahraga adalah sebagai berikut:

- (1) Klien hipertensi sebaiknya melakukan kontrol atau terlebih dahulu tekanan darahnya, sehingga tekanan darah sistolik tidak melebihi 160 mmhg

dan tekanan darah diastolik tidak melebihi 100 mmhg.

- (2) Sebelum berolahraga terlebih dahulu harus memahami atau mengetahui mendapat informasi mengenai penyebab hipertensi yang sedang diderita.
- (3) Sebelum melakukan latihan sebaiknya telah dilakukan uji latih jantung dengan beban (*treadmill/ergometer*) agar dapat dinilai reaksi tekanan darah serta perubahan irama aktivitas listrik jantung (EKG), sekaligus dapat menilai tingkat kapasitas atau kemampuan fisik.
- (4) Pada saat uji latih jantung, maka sebaiknya obat yang sedang diminum klien hipertensi tetap diteruskan sehingga dapat diketahui efektifitas obat terhadap kenaikan beban.
- (5) Latihan fisik yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh klien dan menurunkan tekanan darah.
- (6) Olahraga yang dilakukan tidak bersifat kompetitif dan tidak untuk peningkatan kekuatan.
- (7) Memeriksa tekanan darah secara teratur sebelum dan sesudah latihan.
- (8) Olahraga atau latihan fisik bertujuan untuk menurunkan tekanan darah sehingga olahraga ini dapat menjadi salah satu obat hipertensi.

- (9) Olahraga atau latihan ini selain secara fisik mampu menurunkan tekanan darah, olahraga juga mampu membantu mengendalikan emosi klien. Hal ini dikarenakan kebanyakan klien hipertensi mempunyai beban emosi (stres) sehingga kegiatan olahraga ini berusaha mengatasi ketegangan emosional yang ada.
- (10) Apabila dalam latihan menunjukkan tanda-tanda penurunan tekanan darah, maka dosis/takaran obat yang sedang diberikan sebaiknya dilakukan penyesuaian.

c. Pengaturan Diet

1) Mengurangi konsumsi / asupan garam

Pembatasan konsumsi garam kurang dari 100 meq/l/hari dan meningkatkan asupan buah dan sayuran mampu mengurangi risiko gangguan kardiovaskuler (Setiati et al., 2014). Pengurangan konsumsi garam harus memperhatikan kebiasaan makan klien sehari-hari, termasuk memperhitungkan jenis makanan tertentu yang banyak mengandung garam. Pembatasan asupan garam sampai 60 mmol per hari, berarti tidak menambahkan garam pada waktu makan, memasak tanpa garam, menghindari makanan yang sudah diasinkan, dan menggunakan bahan lain seperti mentega yang bebas garam. Pembatasan asupan garam ini akan sulit

dilaksanakan karena akan mengurangi asupan garam secara ketat dan akan mengurangi kebiasaan makan pasien secara drastis (Tunnur, (2021).

Salman et al., (2020) menjelaskan bahwa kita harus mengurangi dan membatasi natrium (garam) setiap hari agar dapat menurunkan tekanan darah. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan tekanan darah diet antara lain:

- (1) Memperbanyak makanan segar dan mengurangi makanan yang diproses.
- (2) Memilih produk dengan kadar natrium rendah.
- (3) Mengurangi garam pada saat memasak.
- (4) Mengurangi persediaan garam saat di meja makan.
- (5) Membatasi penggunaan saus dan sejenisnya.
- (6) Membilas makanan dalam kaleng yang dikonsumsi (Tunnur, (2021).

2) Mengatur diet rendah lemak

Kadar lemak dalam menu makanan dapat meningkatkan risiko terjadinya aterosklerosis dalam darah dan selanjutnya akan memungkinkan terjadinya kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak jenuh, terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewani sangat

dianjurkan. Peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh secukupnya yang berasal dari minyak sayuran, biji-bijian dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah. Hasil penelitian Irwanto, et al., (2023) menjelaskan bahwa responden yang konsumsi lemak yang tidak mengalami kejadian hipertensi sebanyak 58.5%, dan responden yang konsumsi lemak mengalami hipertensi sebanyak 41.5%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi lemak sangat berisiko terjadinya hipertensi. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa responden dengan status gizi lebih (overweight ataupun obesitas) 9,6 kali lipat lebih berisiko menderita hipertensi jika dibandingkan dengan responden dengan status gizi normal (Diana, et al., (2020).

3) Mengonsumsi buah-buahan dan sayuran

Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa makanan yang mengandung mineral sangat bermanfaat mengatasi hipertensi. Selain mineral, adanya kadar kalium dalam makanan telah terbukti berhubungan erat dengan penurunan tekanan darah arteri dan mampu mengurangi risiko terjadinya stroke. Mengonsumsi kalsium dan magnesium juga bermanfaat dalam membantu menurunkan tekanan darah. Mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan sangat baik untuk menurunkan

tekanan darah, karena buah dan sayuran banyak mengandung kalium, kalsium, magnesium dan mineral. Sayuran yang dikonsumsi antara lain: seledri, kol, jamur (banyak mengandung kalium), dan kacang-kacangan (banyak mengandung magnesium). Kebiasaan mengonsumsi susu dengan memilih produk susu yang mengandung banyak kalsium dan rendah lemak, makan cukup buah dan sayur, rendah gula, garam dan lemak, rajin melakukan aktivitas fisik dan tidak merokok dapat menurunkan tekanan darah (Fauzi, 2020).

4) Mengurangi atau menghindarkan stres

Stres merupakan masalah psikologis klien hipertensi terjadi karena tuntutan yang ada melebihi dari kemampuan klien dalam mengatasinya. Stres sering timbul karena kondisi yang tidak diinginkan terjadi dan tidak sesuai dengan harapan sedangkan mekanisme koping tidak memadai. Salah satu cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan stres adalah dengan melakukan perubahan pola dalam kehidupan rutinitas sehari-hari (Irwanto, et al., (2023).

Khasanah, (2012), menjelaskan bahwa perubahan-perubahan dalam kehidupan rutinitas sehari-hari yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Merencanakan semua kegiatan dengan baik. Dimulai dari membuat jadwal tertulis untuk kegiatan setiap hari sehingga tidak akan terjadi

jadwal kegiatan atau aktivitas yang bertabrakan satu dengan yang lainnya.

- 2) Menyederhanakan jadwal dan melakukan pekerjaan dengan lebih santai.
- 3) Berusaha membebaskan diri dari stres yang berhubungan dengan pekerjaan.
- 4) Mempersiapkan cadangan terkait dengan keuangan
- 5) Melakukan aktivitas fisik atau berolahraga ringan.
- 6) Makan makanan yang adekuat.
- 7) Istirahat atau tidur yang cukup.
- 8) Berusaha mengamati sikap tubuh dan perilaku saat sedang dilanda stres.
- 9) Menyediakan waktu luang untuk keluar dari kegiatan rutin.
- 10) Membina hubungan sosialisasi yang baik.
- 11) Mengubah pola berpikir kearah pola pikir yang mampu menekan perasaan kritis atau negatif terhadap diri sendiri.
- 12) Meluangkan waktu untuk hal-hal yang memerlukan perhatian khusus.
- 13) Menghindari ketegangan dengan melakukan humor.
- 14) Berdoa dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa.

2. Pengelolaan Farmakologi

Pendekatan pengelolaan farmakologis merupakan penatalaksanaan yang utama pada setiap klien hipertensi. Sutanto, (2010) menjelaskan bahwa untuk memulai memberikan obat antihipertensi pada klien hipertensi harus berdasarkan beberapa faktor antara lain berkaitan dengan derajat peningkatan tekanan darah, terdapatnya kerusakan organ target dan terdapatnya manifestasi klinis penyakit kardiovaskuler atau faktor risiko lainnya. WHO merekomendasikan bahwa pemberian obat golongan diuretik dengan dosis kecil sebagai pilihan pertama untuk pengobatan klien hipertensi (Setiati et al., 2014). Hasil penelitian Widyastuti, et.al, (2022) menunjukkan bahwa pemberian obat antihipertensi yang paling banyak diresepkan adalah Angiotensin Receptor Blocker (ARB) dengan jenis obat candesartan. Efektivitas penggunaan obat dilihat dari terjadinya penurunan tekanan darah pada tiap hari rawat sebesar 43,47%, interaksi obat antihipertensi yang terjadi dalam peresepan sebanyak 43,47%.

Sutanto, (2010) menjelaskan bahwa penatalaksanaan klien hipertensi dengan pendekatan farmakologi dapat diberikan obat antihipertensi yang dimulai dengan memberikan dosis rendah kemudian ditingkatkan secara titrasi sesuai umur dan kebutuhan. Penggunaan obat antihipertensi dianjurkan dengan masa kerja panjang atau yang mempunyai efikasi 24 jam

dengan pemberiandalam dosis sekali sehari (Setiati et al., 2014; Sutanto, 2010; Widyastuti, et.al, 2022).

Obat-obatan antihipertensi yang sering digunakan dalam pengobatan, antara lain obat-obatan golongan diuretik, beta blocker, antagonis kalsium, dan penghambat konversi enzim angiotensin (Setiati et al., 2014; Widyastuti, et.al, (2022).

- 1) Diuretika, terutama golongan *Thiazide* atau *Aldosterone Antagonist*.

Obat diuretik ini merupakan golongan anti hipertensi yang dapat merangsang pengeluaran garam dan air. Mengonsumsi diuretika akan terjadi pengurangan jumlah cairan dalam pembuluh darah dan menurunkan tekanan pada dinding pembuluh darah, sehingga mampu menurunkan tekanan darah.

- 2) *Beta Blocker (BB)*

Beta Blocker (BB) dapat mengurangi kecepatan jantung dalam memompa darah dan mengurangi jumlah darah yang dipompa oleh jantung.

- 3) *ACE-Inhibitor*

ACE-Inhibitor merupakan golongan obat antihipertensi yang dapat mencegah penyempitan dinding pembuluh darah sehingga bisa mengurangi tekanan pada pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah.

- 4) *Ca Blocker (CCB)* atau *Calcium Antagonist*

Ca Blocker (CCB) atau *Calcium Antagonist* dapat mengurangi kecepatan jantung dan merelaksasikan pembuluh darah.

5) *Direct Renin Inhibitor (DRI)*

Berdasarkan hasil uji klinis, bahwa hampir seluruh pedoman pengelolaan obat antihipertensi terbukti efektif menurunkan tekanan darah, terlepas dari jenis atau kelas obat yang digunakan. Pengobatan dimulai secara bertahap sampai target tekanan darah tercapai untuk beberapa minggu. Pemilihan obat antihipertensi dengan satu jenis atau kombinasi sangat bergantung pada kondisi tekanan darah awal dan ada tidaknya komplikasi. Apabila pengobatan dimulai dengan satu jenis obat dengan dosis rendah dan apabila tekanan darah belum mencapai target, maka langkah selanjutnya adalah meningkatkan dosis obat tersebut atau berpindah ke obat antihipertensi lain dengan dosis rendah. Penggunaan dosis rendah ini dapat menghindari efek samping obat, baik yang tunggal maupun kombinasi (Setiati et al., 2014; Sutanto, 2010; Widyastuti, et.al, (2022).

Bab 3

Perilaku Upaya Pencegahan Hipertensi

A. Pengertian

1. Perilaku

Perilaku adalah suatu aktivitas seseorang yang bersangkutan dan mempunyai kapasitas yang sangat luas mencakup: berjalan, berbicara, bereaksi, dan berpakaian (Notoatmodjo, 2014). Menurut Windi, (2019) perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati dari luar. Menurut Skinner, perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan dari luar. Berdasarkan bentuk respons terhadap stimulus, perilaku dapat dibagi menjadi dua yakni: perilaku tertutup (Covert Behavior) dan perilaku terbuka (Overt Behavior).

Perilaku tertutup terjadi apabila respon dari suatu stimulus belum dapat diamati oleh orang lain secara jelas. Respon seseorang terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus tersebut. Sedangkan perilaku terbuka apabila respon terhadap suatu stimulus dapat diamati oleh orang lain. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam suatu tindakan atau praktik yang dapat dengan mudah diamati oleh orang lain (Windi, 2019).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Notoatmodjo (2014) menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang yaitu:

a. Faktor Predisposisi (*Predisposing Factors*)

Faktor predisposisi merupakan faktor yang mempermudah terjadinya perilaku seseorang. Faktor predisposisi mencakup pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai dan tradisi.

b. Faktor Pemungkin (*Enabling Factor*)

Faktor pemungkin adalah faktor yang memungkinkan atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat serta jarak dan keterjangkauan tempat pelayanan. Contohnya yaitu puskesmas, posyandu, rumah sakit, klinik dan sebagainya.

c. Faktor Penguat (*Reinforcing Factor*)

Faktor penguat adalah faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku. Faktor penguat ini mencakup sikap dan perilaku tokoh masyarakat, sikap perilaku petugas kesehatan dan sikap perilaku kader kesehatan (HIV/AIDS).

3. Domain Perilaku Kesehatan

Menurut Benyamin Bloom (1908) dalam Notoatmodjo (2014), perilaku dibagi dalam 3 domain. Pembagian domain ini dilakukan untuk kepentingan tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan atau meningkatkan ketiga domain perilaku tersebut, yang terdiri dari ranah kognitif (*cognitive domain*), ranah psikomotor (*psicomotor domain*), dan ranah afektif (*affective domain*) ketiga domain tersebut, diukur dari:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi.

b. Sikap (*Attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut Allport (1954) dalam Notoatmodjo

(2014) menjelaskan bahwa sikap mempunyai tiga komponen pokok:

- 1) Kepercayaan (keyakinan), ide, konsep terhadap suatu objek.
- 2) Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek.
- 3) Kecenderungan untuk bertindak (*tend to behave*).

c. Praktik atau tindakan

Suatu sikap yang terwujud dalam suatu tindakan nyata (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata maka diperlukan suatu fasilitas dan kemampuan.

4. Perilaku pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan perilaku/tindakan mencegah atau menahan agar sesuatu tidak terjadi.

Menurut Susanti, (2019) dalam bukunya Yusnita et.al (2022) bahwa perilaku pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian. Pada dasarnya ada empat tingkatan pencegahan penyakit secara umum yaitu:

a. Pencegahan Tingkat Dasar (*Primordial Prevention*)

Pencegahan tingkat dasar (*Primordial Prevention*) adalah usaha mencegah terjadinya risiko atau mempertahankan keadaan risiko rendah dalam

masyarakat terhadap penyakit secara umum. Pencegahan ini meliputi usaha memelihara dan mempertahankan kebiasaan atau pola hidup yang sudah ada dalam masyarakat yang dapat mencegah meningkatnya risiko terhadap penyakit dengan melestarikan pola atau kebiasaan hidup sehat yang dapat mencegah atau mengurangi tingkat risiko terhadap penyakit tertentu atau terhadap berbagai penyakit secara umum.

Upaya pencegahan ini sangat kompleks dan tidak hanya merupakan upaya dari pihak kesehatan saja. Sasaran pencegahan tingkat dasar ini terutama kelompok masyarakat usia muda dan remaja, dengan tidak mengabaikan orang dewasa dan kelompok manula.

b. Pencegahan Tingkat Pertama (*Primary Prevention*)

Pencegahan tingkat pertama (*Primary Prevention*) merupakan suatu usaha pencegahan penyakit melalui usaha mengatasi atau mengontrol faktor-faktor risiko dengan sasaran utamanya orang sehat melalui usaha peningkatan derajat kesehatan secara umum (promosi kesehatan) serta usaha pencegahan khusus terhadap penyakit tertentu. Pencegahan tingkat pertama ini didasarkan pada hubungan interaksi antara penjamu (host), penyebab pemapar (*agent*), lingkungan dan proses kejadian penyakit.

Sasaran pencegahan tingkat pertama ini ditujukan kepada faktor penjamu seperti perbaikan gizi, pemberian imunisasi, peningkatan kehidupan sosial dan

psikologis individu dan masyarakat serta peningkatan ketahanan fisik individu.

c. Pencegahan Tingkat Kedua (*Secondary Prevention*)

Sasaran utama pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu melalui diagnosis dini serta pemberian pengobatan yang cepat dan tepat. Tujuan utama pencegahan tingkat kedua ini, antara lain untuk mencegah meluasnya penyakit atau terjadinya wabah pada penyakit menular dan untuk menghentikan proses penyakit lebih lanjut serta mencegah komplikasi.

Salah satu kegiatan pencegahan tingkat kedua adalah menemukan penderita secara aktif pada tahap dini. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan berkala pada kelompok populasi tertentu, melakukan penyaringan (*screening*) untuk mencari penderita secara dini, surveilans epidemiologi untuk mendapatkan keterangan tentang proses penyakit yang ada dalam masyarakat.

d. Pencegahan Tingkat Ketiga (*Tertiary Prevention*)

Pencegahan tingkat ketiga (*tertiary prevention*) merupakan pencegahan dengan sasaran utamanya adalah penderita penyakit tertentu, dalam usaha mencegah bertambah beratnya penyakit atau mencegah terjadinya cacat serta program rehabilitasi (Yusnita, et.al, 2022).

Perilaku pencegahan hipertensi menurut Kemenkes (2018) dikenal dengan singkatan CERDIK. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Cek kesehatan secara berkala

Monitor tekanan darah, perhatikan denyut nadi teratur atau tidak, timbang berat badan, ukur tinggi badan dan lingkar perut, cek gula darah dan kolesterol.

2. Enyah Asap Rokok

Bagi perokok segeralah untuk berhenti merokok

3. Rajin aktivitas fisik/olahraga

Lakukan minimal 30, menit per hari 3-5 kali per minggu

4. Diet sehat dan seimbang

Konsumsi buah dan sayur 5 porsi per hari: konsumsi gula, garam, lemak (GGL) sesuai anjuran. Gula tidak lebih dari 4 sendok makan per orang per hari, garam tidak lebih dari 1 sendok teh per orang per hari, lemak/minyak tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. Kurangi konsumsi gula putih/cokelat/merah, madu dan sirup. Kurangi makanan yang mengandung gula tinggi, seperti permen, soft drink (minuman kaleng), kue-kue basah. Gantikan dengan buah segar atau jus buah tanpa gula. Perhatikan makanan/minuman dengan kandungan gula tersembunyi.

5. Istirahat cukup

Sesuai dengan kebutuhan anda (tidur 7-8 jam per hari pada orang dewasa).

6. Kelola Stress

Relaksasi berbicara dengan orang lain, rekreasi, aktivitas

bersamakeluarga, berbuat sesuai kemampuan dan minat, berpikir secara positif dan bijaksana, hidup tertib dan teratur, serta merencanakan masa depan yang sebaik-baiknya (Kemenkes, 2018).

B. Upaya Pencegahan Hipertensi

Tekanan darah pada penderita hipertensi dapat dikontrol dengan cara mempertahankan perilaku pencegahan hipertensi antara lain: dilakukan melalui pendekatan terapi farmakologis dan terapi non farmakologis (Setiyaningsih & Ningsih, 2019). Terapi farmakologis yang sering digunakan dalam pengobatan hipertensi yaitu seperti obat-obatan. Sedangkan terapi non-farmakologis pada penderita hipertensi yaitu dengan menurunkan berat badan bila obesitas, mengurangi konsumsi natrium memiliki hubungan yang sangat erat dengan timbulnya hipertensi, kurangi minuman beralkohol, berolahraga, tidak stress, mengurangi rokok, mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung serat tinggi karena sangat efektif dalam menurunkan kadar kolesterol darah (Iqbal & Handayani, (2022). Perilaku pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan berbagai upaya, baik secara preventif maupun kuratif. Upaya ini dilaksanakan untuk dapat mencegah terjadinya komplikasi hipertensi pada lansia, sehingga perlu adanya peningkatan perilaku pencegahan tentang hipertensi (Isnaini & Lestari, 2018).

Upaya pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan five level of prevention (CDC, 2021), yang meliputi:

1. *Health Promotion*

Health Promotion atau promosi kesehatan bisa diterapkan melalui edukasi terkait faktor risiko hipertensi, komplikasi hipertensi, pola makan, dan pencegahan hipertensi. Advokasi kepada pengelola kebijakan untuk merancang dan melakukan regulasi dalam upaya pencegahan dan penanganan hipertensi serta pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan pada kader posbindu PTM juga dapat dilakukan untuk Health Promotion. Upaya dalam meningkatkan pengetahuan pada masyarakat untuk mencegah hipertensi juga dapat dilakukan dengan memasang spanduk, leaflet, booklet, atau baliho yang berisi tentang pencegahan hipertensi.

2. *Specific Protection*

Specific Protection dapat dilaksanakan dengan cara makan makanan dengan gizi seimbang, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, hindari penyalahgunaan obat, dan mengontrol stres.

3. *Early Diagnosis and Prompt Treatment*

Deteksi dini dan melakukan pemeriksaan secara rutin seperti pemeriksaan tekanan darah secara teratur, pemeriksaan penunjang jika terdapat komplikasi, dan pengobatan antihipertensi pada penderita hipertensi dapat dilakukan dalam upaya pencegahan hipertensi.

4. *Disability Limitation*

Pembatasan kecacatan yang dapat dilakukan dalam pencegahan hipertensi antara lain: pemantauan atau keteraturan pengobatan, melaksanakan pendampingan pada penderita hipertensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pemantauan efek samping pengobatan, dan mengurangi insiden penghentian pengobatan hipertensi.

5. *Rehabilitation*

Rehabilitasi adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk mengembalikan produktivitas orang yang menderita hipertensi dengan mempertahankan kualitas hidup yang optimal. Jika seseorang mengalami komplikasi hipertensi, langkah selanjutnya setelah pengobatan adalah pemulihan dengan pola hidup sehat.

Menurut Yusuf (2014) bahwa hal-hal yang perlu dilakukan bagi penderita hipertensi sebagai tindakan upaya pencegahan adalah sebagai berikut:

1. Diet rendah lemak. Kurangi atau hindari makanan gorengan, daging yang banyak lemak, susu full cream, telur, dan sebagainya.
2. Diet rendah garam. Batasi pemakaian garam dan makanan yang diasinkan seperti cumi asin, ikan asin, telur asin, kecap asin, dan lain-lain.
3. Hindari memakan daging kambing, buah durian, atau minum minuman beralkohol.

4. Lakukan olah raga teratur dan terkontrol. Olah raga yang cocok berupa aktivitas aerobik seperti jalan kaki, berlari, naik sepeda dan berenang.
5. Berhenti merokok bagi perokok.
6. Berhenti minum kopi.
7. Menurunkan berat badan bagi penderita hipertensi yang disertai kegemukan.
8. Menghindari stres dengan gaya hidup yang lebih santai.
9. Mengobati penyakit penyerta seperti kencing manis, hiperthyroid, kolestrol tinggi, resistensi insulin, rematik, guot dan sebagainya.

Menurut Rahma Dinda et.al. (2024) bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan penyakit hipertensi yaitu upaya melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah serta upaya membatasi konsumsi garam. Pentingnya menerapkan perilaku pencegahan hipertensi dengan cara mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh tim Puskesmas, sehingga masyarakat sadar dan mandiri serta mampu terhindar dari penyakit hipertensi sejak dini (Rahma Dinda et.al., 2024).

Bab 4

Pendekatan dan Analisis Faktor Risiko Hipertensi terhadap Perilaku Pencegahan

A. Pendekatan Teoritis

Hipertensi merupakan kondisi kronis yang disebabkan oleh berbagai faktor risiko, baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Beberapa faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap hipertensi antara lain usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, status gizi, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, pola konsumsi makanan dan minuman, tingkat stres, serta aspek psikologis individu (James et al., 2018).

Tanda dan gejala hipertensi sering kali tidak tampak secara nyata pada tahap awal. Manifestasi klinis biasanya muncul setelah bertahun-tahun, terutama ketika organ-organ tubuh mulai mengalami dampak dari tekanan darah yang tinggi. Beberapa gejala yang dapat muncul antara lain nyeri dada, sesak napas, nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, hingga gangguan fungsi ginjal dan jantung (Chobanian et al., 2020). Jika tidak ditangani dengan baik, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal, dan gangguan pada retina mata yang dapat mengakibatkan kehilangan penglihatan (Corwin, 2012; Setiati et al., 2014).

Apabila organ target telah terganggu maka akan timbul gejala antara lain:

1. Nyeri dada dan sesak nafas sebagai akibat gangguan jantung dan diseksi aorta.
2. Nyeri kepala hebat dan nyeri tengkuk karena peningkatan tekanan intrakranial sehingga menyebabkan mual dan muntah.
3. Penglihatan kabur akibat edema papila.
4. Gangguan kesadaran dan lateralisasi sebagai akibat gangguan otak.
5. Adanya peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN) dan serum kreatinin, proteinuria pada pemeriksaan urin atau fungsi ginjal serta gangguan elektrolit.
6. Pada pemeriksaan penunjang elektrokardiografi (EKG) adanya hipertropi ventrikel kiri dan gangguan koroner.

7. Hasil USG didapatkan gambaran gangguan pada struktur ginjal (Sutanto, 2010; Setiati et al., 2014).

Selanjutnya Jika tidak terkontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yaitu: penyakit jantung koroner dan stroke, gagal jantung, gagal ginjal, penyakit vaskular perifer dan kerusakan pembuluh darah retina yang mengakibatkan gangguan penglihatan. Semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi risiko kerusakan pada jantung dan pembuluh darah pada organ besar seperti otak dan ginjal (Depkes, RI., 2019; Setiati et al., 2014).

Untuk mencegah terjadinya komplikasi hipertensi dan risiko kekambuhan, maka dilakukan penatalaksanaan hipertensi, baik yang bersifat farmakologis maupun yang non-farmakologis. Terapi farmakologis yang sering digunakan dalam penatalaksanaan hipertensi yaitu obat-obatan golongan diuretik, beta blocker, antagonis kalsium, dan penghambat konversi enzim angiotensin (Setiati et al., 2014; Sutanto, 2010). Sedangkan pendekatan non-farmakologi pada klien hipertensi merupakan penanganan awal sebelum diberikan obat-obatan anti hipertensi. Sedangkan pada pasien hipertensi yang terkontrol, pendekatan nonfarmakologi ini dapat membantu pengurangan dosis obat-obatan anti hipertensi pada sebagian besar penderita hipertensi. Pengelolaan nonfarmakologi ini dikenal dengan modifikasi gaya hidup antara lain : menurunkan berat badan, mengurangi asupan garam, mengurangi alkohol, berhenti merokok,

meningkatkan asupan buah dan sayur serta meningkatkan aktivitas fisik (Junaedi et al., 2013; Setiati et al., 2014).

Selain penatalaksanaan hipertensi, perlu dilakukan upaya pencegahan hipertensi karena hipertensi sebenarnya dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risiko. Pencegahan primer harus dilakukan untuk menghentikan atau mengurangi faktor risiko hipertensi sebelum penyakit hipertensi terjadi. Pencegahan primer yang dilakukan meliputi: diet sehat dengan makan cukup buah dan sayur, rendah gula, garam dan lemak, rajin melakukan aktivitas fisik dan tidak merokok (Fauzi, 2020). Selain itu, kemampuan pasien dalam melakukan upaya perawatan diri seringkali terbatas, sehingga pemerintah mencanangkan program upaya pencegahan untuk mengendalikan Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan melaksanakan kegiatan promotif dan preventif melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang dilaksanakan oleh Puskesmas (Kemenkes, 2021). Perilaku pencegahan melalui GERMAS ini dapat mengurangi angka kejadian hipertensi hingga 50-60% jika dilakukan secara teratur (Fauzi, 2020).

Menurut WHO (2018) program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit berbasis masyarakat merupakan upaya intervensi yang lazim dilakukan dalam mengelola penyakit kronis termasuk hipertensi dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Selain itu, program berbasis masyarakat juga lebih mampu menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan sosial ekonomi.

B. Pendekatan Analisis

Hipertensi merupakan kondisi kesehatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak. Untuk memahami lebih dalam mengenai hubungan antara faktor risiko dan perilaku pencegahan hipertensi, kajian ini menelaah pola hidup individu serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan risiko hipertensi. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian meliputi obesitas, kebiasaan merokok, tingkat aktivitas fisik, pola konsumsi makanan, serta kebiasaan mengonsumsi alkohol (Hu et al., 2019).

Untuk memahami asosiasi atau hubungan antara faktor risiko dengan perilaku pencegahan hipertensi, pendekatan analisis dilakukan dengan menelaah pola hidup individu serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko hipertensi. Beberapa aspek utama yang diperhatikan dalam analisis ini meliputi obesitas, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, pola konsumsi makanan, serta kebiasaan mengonsumsi alkohol (Hu et al., 2019).

Dalam konteks ini, masyarakat desa yakni klien hipertensi menjadi fokus utama pada kajian buku ini. Melalui observasi dan wawancara mendalam dapat dilakukan untuk memahami pola kebiasaan masyarakat terkait upaya perilaku pencegahan hipertensi. Hasil kajian tersebut akan menunjukkan seberapa besar keterkaitan antara individu (klien) hipertensi dengan gaya hidup yang berisiko, antara lain: kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, serta rendahnya konsumsi buah dan sayur.

Selain itu, beberapa faktor risiko dapat diubah melalui intervensi yang tepat, seperti peningkatan aktivitas fisik, modifikasi pola makan, serta penghentian kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor ini menjadi langkah penting dalam merancang strategi pencegahan yang efektif.

Analisis dilakukan dengan mengamati bagaimana faktor risiko tersebut memengaruhi perilaku pencegahan hipertensi dalam kehidupan sehari-hari. Pengumpulan informasi mengenai faktor risiko hipertensi dan pola pencegahannya dilakukan melalui metode wawancara dan observasi langsung di masyarakat. Salah satu alat yang digunakan dalam kajian ini adalah kuesioner, yang berfungsi untuk menggali informasi seputar kebiasaan hidup masyarakat, termasuk pola makan, aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Setelah data terkumpul, dilakukan proses analisis untuk mengidentifikasi pola serta hubungan antara berbagai faktor risiko dan strategi pencegahan yang diterapkan oleh masyarakat.

Adapun langkah-langkah dalam proses analisis data meliputi:

1. Pemeriksaan dan Penyaringan Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi diperiksa kembali untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya. Jika ditemukan ketidaksesuaian, dilakukan klarifikasi lebih lanjut.

Dalam upaya memahami hubungan antara faktor risiko dan pencegahan hipertensi, pemeriksaan dan penyaringan data menjadi langkah awal yang sangat penting. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, akurat, dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pemeriksaan dan penyaringan data dalam kajian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama:

a. Identifikasi Faktor Risiko Hipertensi

Sebelum melakukan penyaringan data, dilakukan identifikasi awal terhadap faktor-faktor risiko hipertensi yang akan dikaji. Menurut Mulyadi et. al (2023) faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Faktor risiko yang tidak dapat diubah:
 - Usia lanjut (> 45 tahun untuk pria dan > 55 tahun untuk wanita)
 - Riwayat keluarga dengan hipertensi
 - Jenis kelamin (pria lebih berisiko dibandingkan wanita pada usia muda, tetapi risiko meningkat pada wanita pasca-menopause)
- 2) Faktor risiko yang dapat diubah:
 - Obesitas atau kelebihan berat badan
 - Pola konsumsi makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan rendah serat
 - Kurangnya aktivitas fisik
 - Kebiasaan merokok
 - Konsumsi alkohol

- Tingkat stres yang tinggi
- Kurangnya kesadaran terhadap pencegahan hipertensi (Andrianto, 2022).

b. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

Setelah faktor risiko teridentifikasi, data dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain:

- 1) **Data primer** diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan observasi langsung di masyarakat. Individu yang berpartisipasi dalam kajian ini diberikan serangkaian pertanyaan untuk menggali informasi terkait gaya hidup mereka, kebiasaan makan, tingkat aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol.
- 2) **Data sekunder** diperoleh dari catatan kesehatan Puskesmas, laporan penelitian sebelumnya, dan publikasi ilmiah yang membahas kejadian hipertensi di daerah serupa (Julianty Pradono et al, 2020).

c. Pemeriksaan Konsistensi dan Keakuratan Data

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, dilakukan pemeriksaan konsistensi untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan responden sesuai dengan kondisi sebenarnya. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pemeriksaan ini meliputi:

- 1) Verifikasi silang (cross-checking) dengan catatan medis atau sumber data lain untuk memastikan bahwa faktor risiko yang dilaporkan sesuai dengan riwayat kesehatan individu.

- 2) Pemeriksaan jawaban yang tidak konsisten dalam kuesioner, misalnya seseorang yang melaporkan tidak memiliki kebiasaan merokok tetapi memiliki kadar karbon monoksida yang tinggi dalam pemeriksaan fisik.
- 3) Validasi melalui wawancara mendalam, terutama jika terdapat temuan yang tidak sesuai antara data primer dan sekunder. Pada tahap ini tidak boleh ada kesalahan dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur. Adanya kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam proses ini akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel sehingga hasil kajian tidak bisa dipertanggungjawabkan (I Made Sudarma Adiputra, et.al., 2021).

d. Kategorisasi dan Pengkodean Data

Setelah data diperiksa dan disaring, langkah selanjutnya adalah melakukan kategorisasi berdasarkan tingkat risiko. Faktor risiko yang diidentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori berikut:

- 1) **Risiko rendah:** Individu yang memiliki gaya hidup sehat tanpa faktor risiko hipertensi yang signifikan.
- 2) **Risiko sedang:** Individu dengan satu atau dua faktor risiko, seperti pola makan tinggi garam tetapi aktif secara fisik.

- 3) **Risiko tinggi:** Individu dengan beberapa faktor risiko utama, seperti obesitas, merokok, dan konsumsi alkohol secara rutin (Andiyanto, 2022).

Pengkategorian ini akan membantu dalam memahami distribusi risiko dalam populasi serta menentukan strategi pencegahan yang paling efektif bagi setiap kelompok individu.

e. Penyaringan dan Pengolahan Data

Setelah data dikategorikan, selanjutnya dilakukan proses penyaringan data lebih lanjut untuk menghilangkan data yang tidak valid, antara lain:

- Data yang tidak lengkap atau memiliki banyak informasi yang hilang.
- Responden yang tidak memenuhi kriteria inklusi dalam kajian, seperti individu dengan kondisi medis lain yang lebih dominan daripada hipertensi.
- Data yang menunjukkan pola jawaban tidak wajar atau cenderung memberikan jawaban secara acak.

Data yang lolos tahap penyaringan kemudian siap untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode statistik yang sesuai.

2. Pengelompokan dan Pengkodean Data

Informasi yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti pola konsumsi makanan, tingkat aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok

dan konsumsi alkohol. Pengkodean dilakukan untuk mempermudah pengolahan dan penyajian data.

Pengelompokan data merupakan adalah proses untuk mengklasifikasikan informasi yang dapat dilakukan dengan memberikan kode-kode tertentu pada data. Pengelompokan data dapat membantu untuk menyederhanakan data dan dapat meningkatkan akurasi dan konsistensi data.

Pengkodean data adalah proses mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Pengkodean data dapat dilakukan dengan memberikan angka pada setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner yang dapat membantu untuk menyederhanakan judul kolom dalam proses entry data. Pengkodean data dapat membantu peneliti untuk menentukan kualitas abstraksi data hasil kajian.

3. Interpretasi dan Analisis

Interpretasi data merupakan proses menafsirkan data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan wawasan yang bermakna.

Langkah-langkah dalam interpretasi data meliputi:

- a. mengumpulkan data relevan
- b. mengkategorikan data
- c. memanipulasi data
- d. meringkas data
- e. menarik kesimpulan yang relevan

- f. memahami makna terutama dalam kaitannya dengan data lainnya
- g. memberikan makna pada hasil analisis data
- h. menafsirkan hasil analisis dalam konteks pertanyaan penelitian, hipotesis, dan literatur yang ada.

Data yang telah tersusun kemudian dianalisis untuk memahami pola keterkaitan antara faktor risiko dan tingkat keberhasilan upaya pencegahan hipertensi di masyarakat.

Bab 5

Asosiasi Faktor Risiko Hipertensi dengan Upaya Pencegahan Klien Hipertensi

A. Pencegahan Hipertensi melalui Gaya Hidup Sehat

Berdasarkan hasil analisis dan kajian ditemukan bahwa faktor-faktor aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, serta kebiasaan merokok memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencegahan hipertensi (Lee et al., 2021). Individu yang rutin berolahraga dan mengonsumsi makanan sehat cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil dibandingkan dengan mereka yang kurang aktif dan memiliki pola makan yang tidak seimbang. Sebaliknya, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol berkontribusi pada peningkatan risiko hipertensi (Zhou et al., 2020).

Hasil kajian lainnya juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pencegahan hipertensi masih perlu ditingkatkan. Studi yang dilakukan oleh Lim et al. (2022) mengungkapkan bahwa intervensi berbasis komunitas, seperti kampanye kesehatan dan penyuluhan di Puskesmas, mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko hipertensi serta cara mengelolanya.

Program edukasi kesehatan berbasis masyarakat menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran akan hipertensi. Selain itu, WHO (2021) juga menegaskan bahwa intervensi komunitas berbasis gaya hidup, seperti promosi konsumsi makanan rendah garam dan peningkatan aktivitas fisik, telah terbukti efektif dalam mengurangi prevalensi hipertensi.

Dengan demikian, jelas bahwa kajian ini dapat menekankan pentingnya perubahan pola hidup dalam mencegah hipertensi serta perlunya peran aktif dari berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan pemerintah, dalam memberikan edukasi dan dukungan bagi masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah mereka.

B. Asosiasi Faktor Risiko Hipertensi dengan Upaya Pencegahan Klien Hipertensi

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa faktor risiko yang mempengaruhi perilaku pencegahan klien hipertensi yaitu faktor Aktivitas Fisik, Kebiasaan Merokok, Kebiasaan Konsumsi Buah dan Sayur dan Kebiasaan Konsumsi Alkohol.

1. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang meningkatkan pengeluaran tenaga/energi dan pembakaran energi. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengendalikan tekanan darah pada penderita hipertensi. Beberapa aktivitas fisik yang disarankan untuk penderita hipertensi adalah: Jalan kaki, Bersepeda, Yoga, Latihan aerobik dengan intensitas ringan hingga sedang.

Hasil studi yang dilakukan oleh Muhammad Cristanto, Monica Saptiningsih dan Maria Yunita Indriarini (2021) melalui literatur review didapatkan hasil bahwa aktivitas fisik secara signifikan mampu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik dan dapat mencegah Hipertensi serta penyakit tidak menular lainnya. Lama aktivitas fisik yang dianjurkan untuk mencegah hipertensi adalah 150 menit, dengan frekuensi lima hari atau lebih dalam seminggu. Hasil ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik sangat berpengaruh dengan kejadian hipertensi, sehingga setiap klien hipertensi harus melakukan aktivitas fisik sesuai dengan

kemampuan agar mampu mencegah kekambuhan Hipertensi.

Aktivitas fisik sangat erat kaitannya dengan perilaku pencegahan klien hipertensi. Hal ini sesuai dengan hasil studinya Dyah Samsiati, Nurhamidi and Rosihan Anwar (2023) melalui uji korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi dengan nilai $p: 0,007$. Hasil penelitian lainnya yang mendukung yakni penelitian Septiana Ashari et.al, (2024) bahwa berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik ($p=0,001$) dan status gizi ($p=0,008$) dengan kejadian hipertensi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan aktivitas fisik dan status gizi dengan kejadian hipertensi pada pasien rawat jalan Poli Interna di RSUD dr. La Palaloi Kabupaten Maros.

2. Konsumsi Buah dan Sayur

Konsumsi buah dan sayur yang cukup setiap hari dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Adapun manfaat konsumsi buah dan sayur antara lain:

- Meningkatkan kekebalan tubuh
- Menjaga kesehatan tulang dan gigi
- Menurunkan kolesterol
- Melancarkan pencernaan

- Mencegah penyakit jantung, diabetes, stroke, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan

WHO menganjurkan bahwa untuk mencegah dan mengontrol tekanan darah klien hipertensi adalah dengan mengurangi dan mengelola stres, makanan yang sehat yang terdiri dari banyak buah dan sayuran segar yang menyediakan nutrisi antara lain: potasium dan serat, membatasi asupan natrium, menyadari bahwa banyak makanan olahan yang tinggi garam, gula, kopi dan minuman keras (Gunawan, 2012).

Hasil kajian yang terkait dengan faktor risiko kebiasaan konsumsi buah dan sayur menunjukkan hubungan yang signifikan dengan nilai $p:0,000$. Hasil ini sesuai dengan kajian Dyah Samsiati, Nurhamidi dan Rosihan Anwar, 2023 yang didapatkan hasil analisis dengan nilai $p: 0,001$ yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara konsumsi buah dan sayur dengan kejadian hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Martapura I (Dyah Samsiati, Nurhamidi dan Rosihan Anwar, 2023).

Hasil kajian lain yakni dari Andini Fajarwati, et.al (2022) yang menjelaskan bahwa berdasarkan analisis deskriptif bivariate diperoleh hasil 77,8% responden yang hipertensi memiliki asupan buah sayur yang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa asupan buah dan sayur sangat mempengaruhi kejadian hipertensi. Hasil ini sesuai dengan studi kajian Helga Madsen, et. al pada

tahun 2023 melalui systematic review dan studi prospektif meta-analysis, menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara konsumsi buah dan sayuran dengan hipertensi. Hasil ini juga sejalan dengan studi Nouri et.al tahun 2023 yang menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi buah sangat berhubungan dengan penurunan kemungkinan hipertensi (Nouri, et.al, 2023).

3. Konsumsi Rokok dan Alkohol

Telah menjadi jelas selama beberapa dekade terakhir bahwa penggunaan tembakau dan/atau alkohol secara berlebihan mengakibatkan konsekuensi kesehatan yang serius seperti timbulnya penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular, tukak lambung, berbagai kanker, terutama kanker kepala, leher, kerongkongan, dan bahkan hati (Setiati et al., 2014; Sutanto, 2010).

Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan akan berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Salah satu akibat dari konsumsi alkohol yang berlebihan tersebut adalah terjadinya peningkatan tekanan darah yang disebut hipertensi. Alkohol merupakan salah satu penyebab hipertensi karena alkohol memiliki efek yang sama dengan karbondioksida yang dapat meningkatkan keasaman darah, sehingga darah menjadi kental dan jantung dipaksa untuk memompa. Selain itu konsumsi alkohol yang berlebihan dalam jangka panjang akan

berpengaruh pada peningkatan kadar kortisol dalam darah sehingga aktivitas rennin-angiotensin aldosteron system (RAAS) meningkat dan mengakibatkan tekanan darah meningkat (Komaling et al, 2013).

Kajian terkait hubungan konsumsi alkohol dan rokok dengan kejadian hipertensi dapat dijelaskan melalui studi I Gusti Ayu Ninik Jayanti et. al (2017) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi minuman beralkohol dengan kejadian hipertensi pada tenaga kerja pariwisata di Kelurahan Legian (Jurnal Gizi Indonesia. Hasil itu diperkuat dengan studinya Rahardjo, Stevanus Agus dan Samudera, Wahyu Sukma (2021) bahwa terdapat hubungan antara konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi pada remaja di Puskesmas Tompe Kabupaten Donggala, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,732 yang berarti mempunyai kekuatan hubungan kuat dan arah hubungan positif yang berarti semakin sering mengkonsumsi alkohol maka semakin berat pula kejadian hipertensi pada remaja di Puskesmas Tompe kabupaten Donggala.

Hasil kajian lainnya yang mendukung adalah studi Meylin Memah, Grace D. Kandou dan Jeini Ester Nelwan (2019) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi ($p=0,000$, $r=0,726$) dan ada hubungan antara kebiasaan konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi ($p=0,000$, $r=0,799$). Berdasarkan juraian tersebut dapat dijelaskan

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi dengan kekuatan korelasi yang kuat dan arah hubungannya positif, artinya semakin mengkonsumsi rokok dan alkohol, maka akan semakin tinggi risiko terserang hipertensi.

Hasil studi Ningxin Gao et.al. 2023 menunjukkan bahwa perokok berat yang mengkonsumsi melalui rokok mesin gulung memiliki peningkatan risiko hipertensi yang signifikan dibandingkan dengan non-perokok. Selain itu, merokok dan minum alkohol secara bersama2 mampu meningkatkan risiko hipertensi secara signifikan di masa depan. Untuk pencegahan hipertensi, membatasi konsumsi tembakau dan konsumsi alkohol secara bersamaan dapat menghasilkan hasil kesehatan yang lebih baik dalam mengurangi risiko hipertensi (Ningxin Gao, et.al. 2023). Penelitian Alexandre Vallée pada populasi Biobank di Inggris tahun 2023 menunjukkan bahwa merokok dan konsumsi alkohol sangat terkait dengan tekanan darah yang lebih tinggi pada perokok saat ini dengan efek sinergis. Temuan ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan merokok dan konsumsi alkohol dalam pengendalian tekanan darah selain obat antihipertensi dan praktik kesehatan masyarakat (Alexandre Vallée, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa faktor risiko yang mempengaruhi perilaku pencegahan klien hipertensi adalah aktivitas

fisik, kebiasaan konsumsi buah dan sayur, kebiasaan merokok dan kebiasaan konsumsi alkohol. Diantara faktor-faktor risiko hipertensi yang menjadi kajian menunjukkan bahwa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap upaya perilaku pencegahan klien hipertensi adalah faktor kebiasaan melakukan aktivitas fisik.

Bab 6

Penutup

Berdasarkan uraian dan penjelasan di BAB sebelumnya maka penulis dapat memberikan simpulan bahwa hipertensi merupakan kondisi kronis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko, baik yang dapat dikendalikan maupun yang tidak. Faktor-faktor seperti kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, serta konsumsi alkohol memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan risiko hipertensi. Sebaliknya, perilaku pencegahan seperti peningkatan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, serta pengurangan asupan garam terbukti efektif dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan hipertensi masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan intervensi berbasis komunitas. Program seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan sosialisasi di tingkat Puskesmas memiliki potensi besar dalam membantu masyarakat menerapkan pola hidup sehat secara berkelanjutan. Dukungan dari tenaga kesehatan, pemerintah, serta partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi angka kejadian hipertensi dan meningkatkan kualitas hidup individu yang berisiko.

Dengan demikian, upaya preventif melalui perubahan gaya hidup sehat harus menjadi fokus utama dalam menekan prevalensi hipertensi. Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan holistik dan berkelanjutan sangat penting untuk mencapai masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari risiko hipertensi.

Selain itu perlu direkomendasikan hal-hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan Edukasi Kesehatan Masyarakat.

Pemerintah dan tenaga kesehatan perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi terkait hipertensi dan cara pencegahannya melalui media sosial, seminar, serta program berbasis komunitas agar masyarakat lebih memahami risiko serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

2. Penguatan Program Pencegahan Berbasis Komunitas

Program seperti GERMAS dan kegiatan di Posyandu/Puskesmas harus diperkuat dan diperluas cakupannya agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi serta layanan kesehatan terkait hipertensi.

3. Mendorong Perubahan Gaya Hidup Sehat

Individu dengan risiko tinggi hipertensi disarankan untuk lebih memperhatikan pola makan sehat, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti merokok dan konsumsi alkohol.

4. Kerja Sama Multi-Sektor

Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, serta sektor swasta diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung lingkungan sehat, seperti regulasi makanan sehat di sekolah dan tempat kerja, serta fasilitas olahraga yang mudah diakses oleh masyarakat.

5. Kajian Lebih Lanjut

Diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengkaji efektivitas berbagai strategi intervensi dalam pencegahan hipertensi, serta memahami faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi pola hidup masyarakat terkait kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Daftar Pustaka

- Alexandre Vallée. (2023). Associations between smoking and alcohol consumption with blood pressure in a middle-aged population. National Institutes of Health's National Library of Medicine (NIH/NLM). 8600 Rockville Pike. Bethesda, MD 20894. 2023 May 18;21:61. doi: 10.18332/tid/162440.
- Ambarika, R., Agoes, A., & Kristanto, H. (2015). Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Waspada Stroke Pada Kelompok Resiko Tinggi Di Wilayah Kerja Puskesmas Poncokusumo Malang (Pendekatan Teori Health Promotion Model Nolla J Pender). *The Indonesian Journal of Health Science*, 5(2).
- Andini Fajarwati, et.al. (2022). Intake of Fruit Vegetable, High Sodium Food Intake, and Hypertension in Adolescents. *JURNAL KESEHATAN SILIWANGI*. Vol 2 No 3.
- Andrea, K. M. (2013). Hubungan Antara Perilaku Olahraga, Stress Dan Pola Makan Dengan Tingkat Hipertensi Pada Lanjut Usia Di Posyandu Lansia Kelurahan Gebang Putih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. *Jurnal Promkes*, 1. <https://doi.org/10.1109/ISSSTA.2008.47>.
- Aisyah, F. N. (2009). *Faktor Risiko Hipertensi Pada Empat Kabupaten/Kota Dengan Prevelensi Hipertensi Tertinggi Di Jawa Dan Sumatera*. Institut Pertanian Bogor.
- Arif, M., Amalia, E., Sesrianty, V., dan Kartika, K. 2019. Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis Pemberian Intervensi Teknik Relaksasi Autogenik Pada Pasien Hipertensi DI Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis. 1(1), 35-39.
- Barbosa, J. M. V. et al. (2017). Correlates of physical activity counseling by health providers to patients with diabetes and hypertension attended by the Family Health Strategy in the

- state of Pernambuco, Brazil. *Primary Care Diabetes*.
- Barek, P. A. . (2010). Efektivitas Slow Deep Breathing Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Primer di Atambua Nusa Tenggara Timur: *A Randomized Controlled Trial*. Universitas Indonesia.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). High Blood Pressure. <https://www.cdc.gov/bloodpressure/aging.htm>.
- Corwin, E. (2012). Buku Saku Patofisiologi. Jakarta: EGC.
- Cristanto, Muhammad, Monica Saptiningsih, and Maria Yunita Indriarini. "Hubungan aktivitas fisik dengan pencegahan hipertensi pada usia dewasa muda: Literature review." *Jurnal Sahabat Keperawatan* 3.01 (2021): 53-65.
- Diana, Tyra Septi, and Sutanto Priyo Hastono. "Pengaruh Gaya Hidup terhadap Hipertensi pada Remaja: Literature Review." *Faletehan Health Journal* 10.02 (2023): 169-177.
- Dinkes. (2019). *Profil Kesehatan Mojokerto*.
- Dinkes. (2021). *Profil Kesehatan Mojokerto*.
- Dewi, E. I. (2012). *Manajemen Asuhan Keperawatan Ansietas Pada Klien Hipertensi Dengan Pendekatan Model Stres Adaptasi Stuart Di RW 01 dan RW 14 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur*. Universitas Indonesia.
- Dyah Samsiati, Nurhamidi and Rosihan Anwar. (2023). Correlation between Physical Activity, Consumption of Fruits and Vegetables, and Quality of Sleep with Hypertension Incidence. *Jurnal Riset Pangan dan Gizi (JR-Panzi)*. Vol. 05 No. 02.
- Evi Martina, et al. (2022). Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Makan Obat Pada Lansia Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Buhit. *E-Journal.Sari-Mutiara.Ac.Id*, 4(1), 2022. Retrieved from <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/tekesnos/article/download/2907/1988>
- Fitriana, et.al. (2012). Faktor Risiko Kejadian Hipertensi Pada Remaja

- Diwilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(7), 10–15. <https://doi.org/10.1136/pgmj.51.599.683-c>.
- Fitrina, Y., dan Wiryanti, N. 2018. Pengaruh Pemberian Relaksasi Imajinasi Terbimbing Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 9(2), 125-145.
- Gunawan-Lany. (2005). Hipertensi: Tekanan Darah Tinggi. Yogyakarta: Kanisius.
- Hapsari, Y. widya, Frilasari, H., & Triwibowo, H. (2015). Pengaruh Senam Ergonomik Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Di Desa Sumber Agung Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. *Keperawatan*.
- Haryanto, J. (2015). Efektivitas Model Keperawatan Sugesti Pola Tidur Sehat Lansia terhadap Kualitas dan Kuantitas Tidur, Status Kesehatan dan Penurunan Tekanan Darah Lansia Insomnia dengan Hipertensi di Surabaya. Universitas Indonesia.
- Helga Madsen, et.al (2023). Fruit and vegetable consumption and the risk of hypertension: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION* 2023 Aug;62(5):1941-1955. doi: 10.1007/s00394-023-03145-5.
- Iqbal, M. F., & Handayani, S. (2022). Terapi Non Farmakologi Pada Hipertensi.
- I Gusti Ayu Ninik Jayanti, et.al (2017). Hubungan Pola Konsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Tenaga Kerja Pariwisata Di Kelurahan Legian. *The Indonesian Journal of Nutrition*. Vol.6 No.1. e-ISSN: 2338-3119, p-ISSN: 1858-4942.
- I Made Sudarma Adiputra, et.al. (2021). Metodologi Penelitian Kesehatan. Penerbit: Yayasan Kita Menulis.

- Imron Rahmanto, Wahyuning Asih & Fitriana Putri. (2017). Hubungan dukungan keluarga dengan kepatuhan minum obat pada lansia hipertensi di wilayah kerja puskesmas jelbuk kecamatan jelbuk kabupaten Jember. 28, 3–18. Retrieved from <http://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/1030>.
- Indonesian Society of Hypertension (InaSH). (2022). *Konsensus Nasional Hipertensi 2022*. Jakarta: InaSH.
- Irwanto, et.al. (2023). Hubungan Pola Konsumsi Lemak dan Sodium Terhadap Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi Perempuan Etnis Minangkabau. SCIENTIFIC JOURNAL. Vol II No 2: Maret 2023. eISSN : 2810 – 0204.
- Isnaini, N., & Lestari, I. G. (2018). Pengaruh Self-Management Terhadap Tekanan Darah Lansia Yang Mengalami Hipertensi. Indonesian Journal For Health Sciences, 2(1), 7. <https://doi.org/10.24269/Ijhs.V2i1.725>
- Januar, E., & Maywati, Y. F. S. (2014). Beberapa Faktor Risiko Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Pekerja Dipabrik Pakan Ternak Andhika Feedmil Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis Tahun 2014. Universitas Siliwangi.
- James et al.(2018). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet, Volume 392, Issue 10159, 1789 - 1858.
- Kemenkes RI. (2019). *Hipertensi*. Kemnkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2021. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Khasanah. (2012). Waspada Beragam Penyakit Degeneratif Akibat Pola Makan. Yogyakarta: Laksana.
- Komaling et al (2013). Hubungan mengkonsumsi alkohol dengan kejadian hipertensi pada laki-laki di Desa Tompasbaru II

Kecamatan Tompasobaru Kabupaten Minahasa Selatan. E-jurnal keperawatan. 2013; 1:1-7.

- Magfirah, A., Muslima, L., & Sabdi, M. (2021). Penyuluhan Dan Promosi Kesehatan Untuk Pencegahan Hipertensi Di Desa Payatumpi Kabupaten Aceh Tengah. 3 (2), 31–36. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/BAKTIMAS/article/view/3064>
- Meylin Memah, Grace D. Kandou dan Jeini Ester Nelwan (2019). Hubungan Antara Kebiasaan Merokok Dan Konsumsi Alkohol Dengan Kejadian Hipertensi Di Puskesmas Kombi Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. Jurnal KESMAS, Vol. 8 No. 1.
- Mills, K. T., Stefanescu, A., & He, J. (2020). The Global Epidemiology of Hypertension. *Nature Reviews Nephrology*, 16(4), 223–237. <https://doi.org/10.1038/s41581-019-0244-2>
- Mora, L. (2014, July). *Hipertensi Perburuk Kondisi Emosi Penderita*.
- Munawarah, S. (2017). Pengaruh Jalan Santai Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Warga Rw 005 Pisangan Barat Ciputat. [Http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/36040](http://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/36040).
- Ningxin Gao et.al. (2023). Assessing The Association Between Smoking And Hypertension: Smoking Status, Type Of Tobacco Products, And Interaction With Alcohol Consumption. ORIGINAL RESEARCH article. *Front. Cardiovasc. Med. Sec. Cardiovascular Epidemiology and Prevention*. Volume 10 - 2023. doi.org/10.3389/fcvm.2023.1027988.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2014). Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. EDISI, Cet. Ke-2.
- Nouri, et.al. (2023). The relationship between the intake of fruits, vegetables, and dairy products with hypertension: findings from the STEPS study. *BMC Nutrition* (2023) 9:99. doi.org/10.1186/s40795-023-00756-3.
- Pase, M. (2014). Manajemen Kasus Spesialis Klien Lansia Hipertensi Yang Mengalami Ansietas Dengan Pendekatan Stres Adaptasi

- Stuart Dan Model Adaptasi Roy Di Rw 10 Kel Sukadamai Kecamatan Tanah Sereal Bogor. Universitas Indonesia.
- Profil Kesehatan Jawa Timur. (2021)
- Putri, H. E. (2014). Aktivitas Fisik Untuk Mengontrol Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Hipertensi. Universitas Indonesia.
- Putro, K. Z. (2017). Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, Vol. 17, No. 1, 1-8.
- Putu Yuda Hananta & Harry Freitag. (2011). Deteksi Dini dan Pencegahan Hipertensi dan Stroke. Penerbit: Media Pressindo. Yogyakarta .
- Rahardjo, Stevanus Agus; Samudera, Wahyu Sukma. (2021). Hubungan Antara Konsumsi Alkohol Dengan Kejadian Hipertensi Pada Remaja Di Puskesmas Tompe Kabupaten Donggala. *Java Health Journal, [S.l.]*, v. 8, n. 2, nov. 2021. ISSN 2622-9390.
- Riskesdas. (2018). *Riset Kesehatan Dasar Kemenkes RI*
- Rosario, S. (2015). Pengaruh Pemberian Jus Terong Pirus (*Solanum Bateceum*) Terhadap Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi Derajat 1 Di Wilayah Kerja Puskesmas Ibu Kota Payakumbuh Tahun 2015. Universitas Andalas.
- Salman et.al. (2020). Knowledge, attitude and preventive practices related to COVID-19: a cross-sectional study in two Pakistani university populations. PMID: 32395069. PMCID: PMC7210795. DOI: 10.1007/s40267-020-00737-7.
- Satu Data Palapa Mojokerto. (2023)
- Setiati, et.al. (2014). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam (Jilid II Edisi VI). Interna Publishing.
- Setiyaningsih & Ningsih. (2019). Pengaruh Motivasi, Dukungan Keluarga Dan Peran Kader Terhadap Perilaku Pengendalian Hipertensi. *Indonesian Journal On Medical Science*, 6(1), 79–

85.<http://ejournal.poltekkesbhaktimulia.ac.id/index.php/ijms/article>.

Situmorang, P. R. (2015). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Penderita Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Medan. *Keperawatan*, 1(1), 71–74.

SKI. (2023). Survey Kesehatan Indonesia.

Sutanto. (2010). *CEKAL Penyakit Modern Hipertensi, Stroke, Jantung, Kolesterol, dan Diabetes*. Penerbit ANDI .

Swarjana. (2022). Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan – Lengkap Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuesioner. Penerbit: Andi.

Tajuddin, I., & Ramdhani, N. (2011). *Pelatihan Relaksasi Autogenik Untuk Menurunkan Tingkat Stress Pada Penderita Hipertensi*. Universitas Gadjah Mada.

Tunnur, R., 2021. Hubungan Pengetahuan, Asupan Natrium Dan Kalium Dengan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi Di Puskesmas Basuki Rahmad Kota Bengkulu Tahun 2021. Skripsi. Poltekkes Kemenkes Bengkulu.

Utami, P. A. S., Sahar, J., & Widyatuti. (2013). Control of Hypertension Risk Factors among High Risk Elderly People through Home Visits. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 16(1), 11–17. <https://doi.org/10.7454/jki.v16i1.14>

Vionalita, Gisely. (2020). Modul Metodologi Penelitian Kuantitatif. Universitas Esa Unggul. <http://esaunggul.ac.id>.

WHO. (2021). *Hypertension Fact Sheet*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>.

Whelton, P. K., Carey, R. M., Aronow, W. S., et al. (2018). 2017 ACC/AHA Hypertension Guidelines. *Journal of the American*

- College of Cardiology*, **71**(19), e127–e248.
<https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.11.006>
- Windi Chusniah Rachmawati. (2019). PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU. Penerbit Wineka Media: Malang.
- Yunilasari. (2014). Prevelens Dan Faktor Yang Memengaruhi Hipertensi Pada Remaja Siswa Sekolah Menengah Pertama Di Jakarta Pusat. Universitas Indonesia.
- Yusnita, et.al. (2022). DASAR-DASAR EPIDEMIOLOGI. Penerbit : PT. Global Eksekutif Teknologi. Padang.
- Yusuf, D. Y. N. (2014). Gambaran Perilaku Penderita Hipertensi dalam Upaya Mencegah Kekambuhan Penyakit Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Dulalowo Kota Gorontalo Tahun 2013. Universitas Negeri Gorontalo.
- Zhou, B., Carrillo-Larco, R. M., Danaei, G., et al. (2021). Worldwide Trends in Hypertension Prevalence and Progress in Treatment and Control from 1990 to 2019. *The Lancet*, **398**(10304), 957–980. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)01330-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01330-1).

Glosarium

A

AHA: American Heart Association

C

CDC: Centers for Disease Control

D

Depkes: Departemen Kesehatan

F

FPE: Family Psychoeducator

G

GGL: gula Garam Lemak

K

Kemenkes: Kementrian Kesehatan

M

mmHg: Mili meter air raksa

R

RI: Republik Indonesia

S

ST: Supportive Therapy

W

WHO: World Health Organization

Profil Penulis

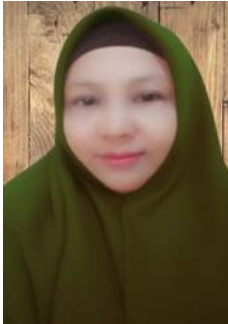


Dr. Faisal Ibnu, S.Pd., S.Kep.Ns. M.Kes.

Lahir di Lamongan, 15 Februari 1972. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Program S1 Ilmu Pendidikan pada Universitas PGRI Adibuana Surabaya tahun 2002, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan pada Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun 2006. Ambil Program S1 Keperawatan dan Profesi Ners lulus tahun 2011. Selanjutnya menempuh program Doktorat Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1997- 1999 bekerja sebagai perawat pelaksana di RSUD Sidoarjo, selanjutnya per 1 Maret 1999 sampai sekarang bekerja di UBS PPNI Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat (UBS) PPNI Mojokerto mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga, Gerontik, Metodologi Penelitian dan Biostatistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar, dan sebagai nara sumber di berbagai instansi. Penulis juga aktif di organisasi profesi sebagai Sekretaris DPD PPNI Kab. Mojokerto dan pengurus Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: faizubspni@gmail.com

Motto: "Life is a journey, so enjoy every step of the way" and "Make your life useful to others"

Profil Penulis



Rina Nur Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom., Lahir di Mojokerto, 11 September 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Imu Keperawatan Universitas Indonesia, lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Indonesia dan lulus tahun 2011. Selanjutnya

melanjutkan pendidikan Spesialis Keperawatan Komunitas pada Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2012. Penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mulai tahun 1999-sekarang mengampu mata kuliah Keperawatan Komunitas, Keluarga dan Gerontik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar maupun narasumber pada area keperawatan komunitas, keluarga dan gerontik. Penulis tergabung dalam pengurus DPK PPNI, pengurus SPBI dan pengurus organisasi Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI) Provinsi Jawa Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinahaqqyraff@gmail.com

Motto: "Break free from the ordinary, explore the extraordinary."
"Never stop learning, growing, and evolving."

Buku Deteksi Faktor Risiko Hipertensi Yang Dapat Dimodifikasi dalam Upaya Perilaku Pencegahan Klien Hipertensi yang telah disusun ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa fakultas ilmu kesehatan dan keperawatan terutama bagi mahasiswa yang dalam proses penyusunan tugas akhir mengenai faktor risiko yang dapat dimodifikasi dalam upaya perilaku pencegahan hipertensi. Materi yang telah disusun dalam buku ini meliputi: Konsep Hipertensi, Faktor Risiko Hipertensi, Dampak Hipertensi dan Pengelolaan Hipertensi, Perilaku Upaya Pencegahan Hipertensi, Kerangka Teori dan Metodologi faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan paya perilaku pencegahan hipertensi serta *Eviden Based* Asosiasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan upaya perilaku pencegahan hipertensi. Buku ini dirancang dengan sistematis mengikuti tata urutan penulisan yang dimulai dari BAB 1: Pendahuluan, BAB 2 – BAB 5 berisi: Konsep Dasar dan Eviden Based dan diakhiri dengan BAB 6 yaitu Penutup, Glosarium, Daftar Pustaka serta biografi penulis. Materi dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ringkas, padat agar memudahkan pembaca untuk memahami isi buku ini secara menyeluruh. Buku ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pada pembaca khususnya tentang faktor risiko yang dapat dimodifikasi dalam upaya perilaku pencegahan hipertensi sehingga mampu pemahaman secara komprehensif tentang faktor risiko hipertensi dan upaya perilaku pencegahan hipertensi.

Buku monograf Deteksi Faktor Risiko Hipertensi Yang Dapat Dimodifikasi dalam Upaya Perilaku Pencegahan Klien Hipertensi yang telah disusun ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa fakultas ilmu kesehatan dan keperawatan terutama bagi mahasiswa yang dalam proses penyusunan tugas akhir mengenai faktor risiko yang dapat dimodifikasi dalam upaya perilaku pencegahan hipertensi. Materi yang telah disusun dalam buku ini meliputi: Konsep Hipertensi, Faktor Risiko Hipertensi, Dampak Hipertensi dan Pengelolaan Hipertensi, Perilaku Upaya Pencegahan Hipertensi, Kerangka Teori dan Metodologi faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan paya perilaku pencegahan hipertensi serta Eviden Based Asosiasi faktor risiko yang dapat dimodifikasi dengan upaya perilaku pencegahan hipertensi. Buku ini dirancang dengan sistematis mengikuti tata urutan penulisan yang dimulai dari BAB 1: Pendahuluan, BAB 2 – BAB 5 berisi: Konsep Dsar dan Eviden Based dan diakhiri dengan BAB 6 yaitu Penutup, Glosarium, Daftar Pustaka serta biografi penulis. Materi dalam buku ini disajikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ringkas, padat agar memudahkan pembaca untuk memahami isi buku ini secara menyeluruh. Buku ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi pada pembaca khususnya tentang faktor risiko yang dapat dimodifikasi dalam upaya perilaku pencegahan hipertensi sehingga mampu pemahaman secara komprehensif tentang faktor risiko hipertensi dan upaya perilaku pencegahan hipertensi.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7139-73-3



9

786347

139733